

HoLEP (Holmium Laser Enucleation)

WARWIKI

रोगी जानकारी · किसी भी आकार के बड़े हुए प्रोस्टेट के लिए लेज़र सर्जरी

HoLEP एक लेज़र सर्जरी है जो बड़े हुए प्रोस्टेट (BPH) के लिए की जाती है। इसमें scope के ज़रिए बाधा डालने वाला अंदरूनी हिस्सा हटाया जाता है — कोई बाहरी चीरा नहीं लगता। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह किसी भी आकार के प्रोस्टेट पर काम करती है — यहाँ तक कि बहुत बड़े प्रोस्टेट पर भी — कम रक्तस्राव के साथ और दीर्घकालिक परिणामों के साथ।

इस प्रक्रिया के बारे में

मूत्रमार्ग में डाले गए scope के ज़रिए, **holmium laser** प्रोस्टेट के पूरे अंदरूनी हिस्से (जो रुकावट पैदा कर रहा है) को उसके बाहरी खोल से अलग कर देती है — जैसे फल को उसके छिलके से निकाला जाता है। इस अलग किए गए टिशू को मूत्राशय में धकेलकर तोड़ा और निकाला जाता है (**morcellation**)। चूँकि पूरा रुकावट पैदा करने वाला हिस्सा हटाया जाता है, इसलिए परिणाम **दीर्घकालिक** होते हैं और दोबारा इलाज की ज़रूरत शायद ही पड़ती है।

HoLEP क्यों चुनें

- **किसी भी आकार** के प्रोस्टेट के लिए उपयुक्त, बहुत बड़े प्रोस्टेट के लिए भी
- **कम रक्तस्राव** — अक्सर खून पतला करने वाली दवाएँ लेने वालों के लिए भी सही
- कम समय के लिए catheter और दीर्घकालिक परिणाम

यह एक विशेष तकनीक है — अनुभवी सर्जन के साथ बेहतर परिणाम मिलते हैं।

शब्दों को समझें

HoLEP

प्रोस्टेट का holmium laser enucleation।

BPH

बढ़ा हुआ प्रोस्टेट (कैंसर नहीं)।

Enucleation

प्रोस्टेट के पूरे अंदरूनी हिस्से को बाहरी खोल से निकालना।

Holmium laser

वह लेज़र जो टिशू को अलग करती और कम रक्तस्राव के साथ बंद करती है।

Morcellation

निकाले गए टिशू को छोटे टुकड़ों में तोड़ना।

प्रतिगामी वीर्यपात

Dry orgasm — एक सामान्य, हानिरहित दुष्प्रभाव।

बाद में क्या बदलेगा? अधिकतर पुरुषों को तेज़ और स्थायी पेशाब की धारा मिलती है। अन्य प्रोस्टेट सर्जरियों की तरह, **प्रतिगामी वीर्यपात** (dry orgasm) सामान्य है। पहले कुछ हफ्तों में कुछ पुरुषों को अस्थायी urgency या हल्का मूत्र असंयम हो सकता है जो लगभग हमेशा ठीक हो जाता है; स्तंभन दोष या स्थायी मूत्र असंयम असामान्य है।

तैयारी कैसे करें

- **जनरल या स्पाइनल एनेस्थीसिया** दी जाती है — उपवास और दवाओं के निर्देशों का पालन करें।
- पहले **पेशाब की जाँच** (urine test) ताकि संक्रमण न हो।
- किसी के साथ आएँ; थोड़े समय के catheter की तैयारी रखें।

क्या होता है & बाद में

- 1 आप बेहोश या सुन्न होते हैं; antibiotics दिए जाते हैं।
- 2 लेज़र से प्रोस्टेट का अंदरूनी हिस्सा निकाला जाता है, फिर morcellation से बाहर किया जाता है।
- 3 catheter लगाया जाता है, जो आमतौर पर **एक दिन में** हटाया जाता है; अधिकतर लोग उसी दिन या एक रात में घर जाते हैं।

कुछ हफ्तों तक **पेशाब में हल्का खून** और जलन/urgency हो सकती है; सलाह दी जाए तो पेल्विक फ़्लोर व्यायाम करें और भारी उठाने से बचें।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- catheter हटने के बाद **पेशाब नहीं** हो रहा
- **भारी रक्तस्राव या clots** जो पेशाब रोक रहे हों
- बुखार या ठंड लगना
- पहले हफ्तों में मूत्र असंयम ठीक न हो

याद रखने योग्य तीन बातें

1. HoLEP लेज़र से scope के ज़रिए पूरा रुकावट करने वाला प्रोस्टेट हटाती है — **किसी भी आकार** के लिए, कम रक्तस्राव और दीर्घकालिक परिणाम।
2. तेज़ पेशाब की धारा मिलती है; dry (प्रतिगामी) वीर्यपात सामान्य है, और शुरुआती urgency/असंयम आमतौर पर ठीक हो जाता है।
3. catheter का समय कम है। पेशाब न होने, भारी रक्तस्राव, या बुखार पर तुरंत बुलाएँ।